

RECURSO CÍVEL Nº 5060827-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

SAÚDE - APNEIA OBSTUTIVA DO SONO - FORNECIMENTO DE APERELHO DE PRESSÃO POSITIVA - PRESCRIÇÃO DE USO PROVENIENTE DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL - CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO PELA CÂMARA DE LITÍGIOS EM SAÚDE E PELO NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES DE SAÚDE - INSUMO DISPONIBILIZADO PELO SUS POR MEIO DE FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO SIGEM PARA O SERVIÇO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO AMBIENTE DA ATENÇÃO DOMICILIAR - A UTILIZAÇÃO DO CPAP NA ATENÇÃO DOMICILIAR É REGULAMENTADA PELA PORTARIA MS Nº 963, DE 27 DE MAIO DE 2013 - RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA TUTELA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPONSÁVEL PRIMÁRIO PELA ATENÇÃO BÁSICA OBSERVANDO TEMA DO STF.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para direcionar o cumprimento da sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos termos do Tema 793 do STF, dado tratar-se do ente prioritariamente responsável pela Atenção Básica, para que proceda à aquisição e à disponibilização do equipamento em favor do autor por meio do SIGEM/RENEM, na forma da fundamentação deste voto. Inviável o cumprimento da sentença em face do Município, a tutela deverá ser direcionada ao Estado do Rio de Janeiro. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, ante a modificação da sentença de ofício. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5060827-77.2024.4.02.5101

510015491876 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5060827-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão autoral consiste no fornecimento de um APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA E FIXA NAS VIAS AÉREAS, MÁSCARA FACIAL E TUBO CONECTOR. A parte autora, em acompanhamento junto ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ, foi diagnosticado com APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (CID-10 G47.3), sendo-lhe prescrita a utilização dos supramencionados insumos.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, preliminarmente, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos da parte autora.

VOTO

Por outro lado, a preliminar arguida pela União de ilegitimidade passiva já foi tratada e afastada pelo juízo *a quo*, à luz do artigo 196 da CF. Neste sentido, vale, ainda, invocar o Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 43 TR-SJRJ - A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.

Na mesma linha, o artigo 198 da Constituição Federal introduziu o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo competência concorrente às três esferas do Poder Executivo sobre as ações e os serviços públicos de saúde em geral, e com o escopo de regulamentar o dispositivo constitucional, foi editada a Lei nº 8.080/90, a qual prevê, em seu artigo 6º, inciso I, alínea d, que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, **inclusive farmacêutica**. O mesmo diploma legal dispõe, em seu artigo 9º, que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) será exercida em cada esfera de governo por órgãos distintos, sendo no âmbito da União a cargo do Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, devendo, portanto a responsabilidade ser repartida entre as três autoridades supra mencionadas.

Solidária, portanto, é a responsabilidade dos entes políticos da federação pelo atendimento hospitalar e ambulatorial, bem como ao fornecimento de medicamentos/insumos.

Nesse sentido, inclusive, a Excelsa Corte fixou tese de repercussão geral, consoante notícia a seguir transcrita:

"Decisão: Preliminarmente, votou o Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019". (STF - Plenário - RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019 - Informativo 941)

No caso, **o CPAP encontra-se incorporado ao SUS** para tratamento de pacientes com quadro de carência respiratória em ambientes de atendimento domiciliar e a pacientes com apneia obstrutiva do sono com respiração espontânea, em que pese não tenha sido avaliado pela CONITEC.

A utilização do CPAP na atenção domiciliar é regulamentada pela Portaria MS nº 963/2013:

Art. 18. A Atenção Domiciliar será organizada em três modalidades:

(...)

III - Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3).

Parágrafo único. As modalidades previstas no "caput" observarão a complexidade e as características do quadro de saúde do usuário, bem como a frequência de atendimento necessário.

Art. 24. A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção à saúde.

Art. 25. Para que o usuário seja incluído para cuidados na modalidade AD3, é necessário que se verifique:

I - existência de pelo menos uma das situações admitidas como critério de inclusão para cuidados na modalidade AD2; e

II - necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes equipamentos/procedimentos:

a) Suporte Ventilatório não invasivo:

i. Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP);

ii. Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP);

b) diálise peritoneal; ou

c) paracetese.

Parágrafo único. Na modalidade AD3 será garantido transporte sanitário e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, definidas previamente como referência para o usuário, nos casos de intercorrências.

O CPAP consta na relação Nacional de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais permanentes para o SUS (SIGEM) sob o Código 626. Possui procedimentos associados ao uso no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMs do SUS (SIGTAP), sob o código 03.01.05.001-5 para o procedimento ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTE SUBMETIDO À VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA - paciente/mês. É passível de financiamento pelo SiGEM no ambiente da Atenção Domiciliar pelo serviço Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde.

O CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais, etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), por meio de termos de cooperação, repasses do tipo fundo a fundo e convênios, que são instrumentos legais para a formalização de transferências voluntárias do MS para o aprimoramento do aparelhamento tecnológico do SUS. **O CPAP não é um item dispensado pelo MS diretamente aos pacientes, mas sim financiado através dos instrumentos citados, cabendo à entidade solicitante a sua devida alocação e manutenção junto aos pacientes que necessitam de terapia suportada pelo equipamento.**

Portanto, **o CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde, cabendo à unidade responsável pela atenção domiciliar adquiri-lo e colocá-lo a disposição do paciente.**

No caso, trata-se de Autor com diagnóstico de Síndrome da Apneia do Sono em grau acentuado (SAHOS) (evento 1, ANEXO2, Página 7 - laudo emitido pelo **Hospital Universitário Clementino Fraga Filho**), solicitando o fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) e máscara nasal (Tamanho M) (Evento 1, INIC1, Página 6). Tanto o médico do SUS (fl. 7 do evento 1, ANEXO2), quanto o NAT e a CRLS (fl. 12 do evento 1, ANEXO2), informaram que o uso do aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) e máscara nasal (Tamanho M) está indicado ao manejo do quadro clínico do Autor - Síndrome da Apneia do Sono em grau acentuado (SAHOS).

Conforme demonstrado acima, o CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde para atendimento na Atenção Domiciliar, em que pese não tenha sido avaliada sua incorporação pela CONITEC e o Estado do Rio de Janeiro ou o Município não o forneçam.

Assim sendo, **tratando-se de insumo passível de disponibilização no SUS para atendimento do caso autor, bem como configurada a necessidade do insumo, não existe razões concretas para o indeferimento do pedido autor.**

A argumentação do Estado, ora recorrente, é genérica e não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da sentenças.

Por outro lado, deve ser **esclarecido que o fornecimento deve ser efetivado por meio de acompanhamento e requerimento do Município no âmbito do SIGEM**, dado tratar-se de item constante da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) - 626.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, para direcionar o cumprimento da sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos termos do Tema 793 do STF, dado tratar-se do ente prioritariamente responsável pela Atenção Básica, para que proceda à aquisição e à disponibilização do equipamento em favor do autor por meio do SIGEM/RENEM, na forma da fundamentação deste voto. Inviável o cumprimento da sentença em face do Município, a tutela deverá ser direcionada ao Estado do Rio de Janeiro. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Deixo de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, ante a modificação da sentença de ofício. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.